



Диаграмма 4. Динамика удельного веса запущенных форм рака молочной железы в РК и г.Алматы за 2005-2010 г. (%)

женщины со злокачественной опухолью молочной железы, из них: с I стадией – 7 (21%), со IIa – 18 (55%), со IIb – 4

(12%), с III – 4 (12%), с IV – 0, т.е. удельный вес ранних форм составил 76%.

Выводы

Заболеваемость РМЖ в РК остается по-прежнему высокой (19,5- 20,6‰), находится на 1 месте в структуре онкологической заболеваемости у женщин. В г.Алматы заболеваемость по РМЖ остается одной из самых высоких в РК (33‰-33,5‰), занимает 1-е место в структуре общей онкологической заболеваемости.

Применение маммографического скрининга способствует повышению удельного веса ранних форм РМЖ, что несомненно приведет к повышению эффективности лечения РМЖ и улучшению прогноза заболевания.

Полимодальное лечение послеоперационной боли

Денисенко Э.В.

Отделение анестезиологии и реанимации онкодиспансера г. Алматы

В настоящее время одной из актуальных проблем послеоперационного периода остается поиск более эффективных методов обезболивания.

Операционная травма и сопровождающая её боль является пусковым механизмом стресс-реакции. Будучи мощным стимулятором вегетативной нервной системы, боль опосредованно оказывает отрицательное воздействие на функции различных органов и систем. Напряжение функций этих систем, прежде всего кровообращения и дыхания, проявляется повышением давления, тахикардией, нарушением сердечного ритма, учащением дыхания и т. д. Конечным звеном этих реакций является нарушение периферического кровообращения, которое может перечеркнуть весь труд хирурга.

К другим клиническим проявлениям стресс-реакции относятся снижение двигательной активности, «вынужденное» положение тела, неспособность откашливать мокроту и глубоко дышать.

Наконец, неэффективное обезболивание в первые сутки послеоперационного периода, возможно, служит одной из причин формирования впоследствии хронического болевого синдрома (ХБС), который может сохраняться у пациентов длительное время.

Углубленное изучение патофизиологии послеоперационного периода привело к тому, что первоначальная вера в адаптационную мудрость организма, когда его стресс-реакция на травму рассматривалась как необходимый для выживания компенсаторный механизм, сменилась осознанием необходимости максимального подавления стресс-ответа. Отсюда следует вывод, что адекватная анальгезия может и должна улучшить исход хирургического лечения.

Классический метод обезболивания наркотиками блокирует центральные механизмы болевого синдрома, но не устраняет причину, имея массу нежелательных побочных эффектов. Последние десятилетия всё больше внимания обращается на изучение периферических механизмов возникновения боли и способы её устранения. Современное представление о механизмах возникновения болевого синдрома и последствиях для организма в целом следующее: при обширной травме тканей медиаторы, выделяющиеся в месте повреждения (серотонин, цитокины, лейкотриены, простагландины), стимулируют полимодальные ноцицепторы, которые вновь усиливают выделение медиаторов, снижая таким образом порог болевой чувствительности (первичная гипералгезия). Местный отек тканей вследствие нарушения проницаемости капилляров под воздействием гистамина, брадикинина еще более сенситизирует рецепторы (вторичная гипералгезия).

В настоящее время одной из актуальных проблем послеоперационного периода остается поиск более эффективных методов обезболивания.

На практике применен метод полимодального послеоперационного обезболивания, что в условиях онкологического диспансера г.Алматы позволило уменьшить расход наркотических анальгетиков и улучшить результаты лечения онкобольных.

Локальный воспалительный процесс является причиной формирования системного ответа на повреждение, что проявляется увеличением концентрации белков острой фазы (С – реактивный белок, фибриноген, плазменный альбумин). Затем происходит активация ряда медиаторных систем (кининовая, системы комплемента, липидных медиаторов и цитокинов).

Таким образом, выраженный воспалительный ответ для организма в большей степени является разрушительным, нежели защитным. Первые двое суток послеоперационного периода являются определяющими для прогноза исхода хирургического лечения и предъявляют особые требования к выбору метода и качеству послеоперационного обезболивания.

Исходя из этого представления о периферическом механизме боли, формируются и современные схемы профилактики и лечения послеоперационного болевого синдрома. Патогенетически оправдано использование анальгетиков периферического действия из ряда нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), ингибирующих медиаторы боли и модуляторы воспаления. Доказана и эффективность препаратов типа контрикала – ингибитора синтеза брадикинина.

Хорошо известно и очень важно то, что боль, вызванная хирургическим повреждением тканей, сопровождается спазмом гладкой мускулатуры. Механизм возникновения спазма достаточно сложный, но при рассмотрении патогенеза боли в современной литературе этой взаимосвязи уделяется мало внимания.

Неоспоримо и то, что спазм порождает или усиливает боль. Интересно также то, что связь боли и спазма замыкается на уровне спинного мозга и не контролируется головным мозгом. Образуется замкнутый круг, поддерживающий болевую импульсацию, отягощающую течение послеоперационного периода.

Исходя из этого, становится логичным то, что наркотики не всегда эффективны при спастических болях, мы просто ослабляем восприятие боли за счёт центрального, седативного эффекта, но не устраняет спазм. Эта седация, с одной стороны,

полезна. Но она же и является минусом применения наркотиков в послеоперационном периоде, когда для профилактики осложнений требуется ранняя активизация больных. Другой минус – угнетение дыхания, функций желудочно-кишечного тракта.

Применяя НПВП – периферический анальгетик, мы уменьшаем болевую импульсацию и ингибируем гуморальные факторы боли, но кардинально не устраняем спазм. Возможно, именно с этим связана недостаточная эффективность НПВП после операций на органах желудочно-кишечного тракта, где спазм гладкомышечной мускулатуры имеет большое значение в генерации боли.

Используя принцип полимодальности, на кафедре анестезиологии и реаниматологии АГИУВ теоретически было обосновано применение комбинации НПВП и миотропного спазмолитика (Но-шпа) в послеоперационном периоде (2006г).

Современные концепции послеоперационного обезболивания определяются желанием как можно меньше использовать наркотические анальгетики. Исходя из этого, было предположено, что предлагаемая комбинация позволит реже применять наркотики, достигнув их уровня эффективности при использовании НПВП.

Рассмотрев проблему послеоперационного обезболивания, были сформулированы основные принципы современных подходов к её решению:

Максимальное ограничение использования наркотических анальгетиков и их аналогов (только по необходимости и при неадекватности других методов обезболивания).

Широкое использование современных НПВП, обладающих эффективным действием на разные компоненты болевого синдрома. При грамотном и кратковременном использовании риск развития осложнений со стороны ЖКТ минимальный.

Многокомпонентность послеоперационного обезболивания – использование нескольких препаратов, действующих на различные компоненты болевого синдрома.

Превентивное обезболивание – предупреждение возник-

новения боли – введение препаратов до развития болевого синдрома, по часам.

Данная концепция была реализована на практике в следующем виде. Во время операции вводятся ингибиторы гуморальных факторов боли (например – контрикал 50 тыс ЕД). Сразу после операции, ещё до пробуждения, вводится НПВП и Но-Шпа (базовая анальгетическая терапия). Далее эта комбинация вводится с интервалом в 6-8 часов, вне зависимости от наличия боли. Кратность введения зависит от применяемого НПВП – его суточной разрешённой дозировки. Наркотические анальгетики (промедол, стадол и т.п.) вводятся только по требованию – при неэффективности базовой анальгетической терапии.

На практике предложенная схема послеоперационного обезболивания показала высокую эффективность. При достаточном уровне обезболивания расход наркотических анальгетиков после неполостных операций уменьшился на 76%, после полостных малотравматичных – на 69%, после объёмных травматичных вмешательств на желудке и пищеводе – на 62%.

Литература

- Лебедева Р.Н., Никода В.В. *Фармакотерапия острой боли.* – М., 1998.
- Н.А. Осипова. Антиноцицептивные компоненты общей анестезии и послеоперационной анальгезии. //Анестезиология и реаниматология, № 5, 1998.
- Савенков П.М. и др. Применение но-шпы у больных с грудной жабой. //Кардиология, 1968, №8, с.46-48.
- Чурсин В.В., Тулеусаринов А.М., Веселова Т.В. Лечение болевого синдрома у онкологических больных. Материалы IV съезда онкологов, рентгенологов и радиологов РК, - Алматы, - 2001г, -С. 379-384.
- Ферранте Ф.М. и др. Послеоперационная боль. Перевод с английского проф. Карачунского М.А., Мельниковой Е. В., -М., - 1998.